Et toi, qui prend soin de toi ?

Le grand oubli des aidants naturels neurodivergents

Cet article s'adresse à celles et ceux qui vivent au quotidien avec un conjoint autiste, des enfants TDAH ou HPI — et qui sont, eux aussi, concernés par la neurodiversité. À ceux qui ont tout lu sur l'autisme, tout compris sur le TDAH, et qui se retrouvent pourtant seuls face à leur propre épuisement.

Il part d'une expérience vécue de l'intérieur — pas d'une étude généralisable. Ce que le vécu ne peut pas prouver à grande échelle, il peut le nommer. Et parfois, être nommé suffit.

Vous reconnaissez-vous dans ces phrases ?

> *"Je comprends son fonctionnement, alors je m'adapte. Tout le temps."*

> *"Je ne peux pas lui en vouloir, il fait ce qu'il peut."*

> *"J'ai suivi des formations, lu des livres, rejoint des associations. Mais c'était pour mieux l'aider, pas pour parler de moi."*

> *"Les autres me disent que je suis forte. Mais je suis juste… épuisée."*

Si vous vous reconnaissez dans l'une de ces phrases, cet article est pour vous. Non pas pour vous expliquer une nouvelle fois comment fonctionne l'autisme ou le TDAH. Vous savez déjà. Mais pour poser enfin la question que personne ne pose : **et vous, comment vous en sortez-vous ?**

La figure invisible : l'aidant naturel adulte

Dans le monde de la neurodiversité, on parle beaucoup des personnes concernées — et c'est légitime. On parle des enfants autistes, des adultes TDAH, des profils HPI. On parle aux parents. On explique, on sensibilise, on forme.

Mais il existe une catégorie de personnes que la littérature, les associations et les professionnels de santé tendent à oublier : **le conjoint ou la conjointe de la personne neurodivergente**.

Pas le parent. Le partenaire. Celui ou celle qui partage la vie, le lit, les finances, les décisions, l'espace mental — avec quelqu'un dont le cerveau fonctionne différemment.

Et lorsque cette personne est elle-même neurodivergente — TDAH, HPI, hypersensible — on parle alors d'une situation que l'on pourrait appeler la **double, voire triple aidance invisible**.

Ce que les ressources existantes ne disent pas

Ouvrez n'importe quel livre sur l'autisme Asperger destiné aux familles. Ouvrez les sites des associations. Suivez une formation de proche aidant dans un centre spécialisé.

Vous trouverez des explications précieuses sur le fonctionnement autistique. Vous comprendrez mieux les crises, les routines, la communication littérale, l'épuisement sensoriel, le masking.

Ce que vous ne trouverez pas :

- Comment survivre, vous, à la charge émotionnelle permanente
- Comment gérer votre propre épuisement quand vous êtes aussi concerné(e)
- Comment ne pas vous dissoudre dans le rôle d'aidant au point de ne plus savoir qui vous êtes
- Comment maintenir une vie à vous, des désirs à vous, une identité à vous
- Comment parler à votre conjoint(e) de *vos* besoins, quand ses propres besoins occupent déjà toute la place

Les ressources disponibles vous apprennent à mieux comprendre l'autre. Elles ne vous apprennent pas à vous préserver.

Et certains discours, aussi bienveillants soient-ils, finissent par être culpabilisants. Comprendre le handicap de l'autre devient presque une injonction à tout accepter, tout absorber, sans jamais nommer ce que ça coûte.

L'aidant qui est lui-même atypique : une situation hors-cadre

Imaginez maintenant que vous soyez vous-même TDAH. Ou HPI. Ou les deux.

Que votre propre cerveau carbure en permanence, génère une charge mentale tentaculaire, peine avec les fonctions exécutives, déborde d'idées et manque de structure.

Et que vous deviez, en même temps :

- Gérer le quotidien d'un foyer avec un conjoint autiste dont les routines et besoins sensoriels structurent l'organisation de la maison
- Accompagner un ou plusieurs enfants neurodivergents dans leur scolarité, leurs rendez-vous, leurs crises, leur épanouissement
- Contenir votre propre hypervolubilité pour ne pas surcharger un conjoint en épuisement cognitif
- Freiner votre énergie naturelle pour ne pas "déranger" les gens
- Vous inscrire dans des associations qui vous donnent des conseils pour gérer vos enfants TDAH — mais aucun pour gérer votre propre TDAH d'adulte, dans une famille neurodivergente

Cette situation est encore peu documentée dans la littérature spécialisée. Elle est rarement accompagnée.

Et pourtant, de nombreuses personnes la vivent, souvent en silence.

Ce que Rudy Simone a osé dire (et qu'on ne traduit pas assez)

Dans son livre *22 Things a Woman Must Know If She Loves a Man with Asperger's Syndrome*, la chercheuse et autrice Rudy Simone, elle-même Asperger, a eu le courage de s'adresser directement aux femmes qui aiment un homme autiste — pas pour leur expliquer l'autisme, mais pour leur parler d'elles.

Elle aborde ce que peu osent nommer : le sentiment de solitude dans le couple, le déséquilibre émotionnel permanent, le fait de porter seule la relation, l'érosion progressive de sa propre identité. Elle valide la souffrance de la partenaire sans pour autant dénigrer la personne autiste.

Ce livre est en anglais. Il n'existe pas d'équivalent en français. C'est précisément ce manque que cet article cherche à combler.

Ce que vous vivez a un nom : l'épuisement de l'aidant

L'épuisement de l'aidant — ou *caregiver burnout* — est reconnu par les professionnels de santé. Il se caractérise par une fatigue chronique qui ne se résout pas avec le repos, une perte progressive de la capacité à ressentir de la joie, un sentiment d'être piégé dans un rôle, et parfois une anesthésie émotionnelle complète.

Les neurosciences offrent un cadre explicatif documenté : soumis à un stress prolongé, le cerveau sécrète du cortisol en continu — ce que le physiologiste Hans Selye appelait dès les années 1930 la "phase d'épuisement du syndrome général d'adaptation". Selon des mécanismes largement décrits en neurosciences, une exposition prolongée au cortisol affecte l'hippocampe — impliqué dans la mémoire et la régulation émotionnelle — tandis que l'amygdale, notre système d'alerte interne, tend à s'emballer, rendant le quotidien plus difficile à réguler. Ce modèle est une simplification utile, pas une équation absolue : chaque cerveau réagit différemment.

Ce qui est moins reconnu, c'est que cet épuisement peut survenir même lorsque la personne aidée n'a pas de handicap institutionnellement reconnu. Un conjoint Asperger sans diagnostic officiel, un enfant TDAH qui "s'en sort bien à l'école" — leur entourage s'épuise tout autant.

Ce que cet article ne fera pas

Cet article ne va pas vous dire que tout va bien se passer si vous "prenez du temps pour vous" ou "pratiquez la pleine conscience".

Il ne va pas vous proposer une checklist de 10 étapes pour être un meilleur aidant.

Il ne va pas non plus vous demander d'être plus patient(e), plus compréhensif(ve), plus adaptable.

Vous l'êtes déjà. Depuis longtemps. Trop longtemps peut-être.

Ce qui va suivre : des outils concrets, ancrés dans le réel

Les conseils qui suivent s'appuient sur une expérience personnelle vécue de l'intérieur — en tant que conjointe d'un homme autiste Asperger, mère d'un enfant autiste et d'une fille TDAH, et adulte TDAH/HPI elle-même — croisée avec des apports issus des neurosciences et de la Communication Non Violente. Ils ne prétendent pas à une portée universelle : ils éclairent une configuration familiale spécifique, encore peu documentée.

💡 Conseil n°1 — S'occuper de soi en premier : ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la neurobiologie

Le discours ambiant dans le monde de l'aidance invite à "penser aux autres d'abord". C'est contre-productif — et les neurosciences apportent des éléments d'explication.

Sous stress chronique, le cerveau tend à mobiliser davantage ses circuits d'alerte — ce qui peut progressivement réduire la disponibilité du cortex préfrontal, impliqué dans le raisonnement, l'empathie et la régulation émotionnelle. En clair : plus on s'épuise, moins on est disponible pour ceux qu'on aime. Ce n'est pas un échec moral. C'est une réalité physiologique documentée.

Prendre soin de soi n'est donc pas un luxe. C'est une condition pour continuer à prendre soin des autres.

La CNV — Communication Non Violente développée par Marshall Rosenberg — offre un outil concret : **l'auto-empathie**. Avant de chercher à comprendre les besoins de l'autre, il s'agit d'identifier les siens propres, sans jugement. Quelles sont mes émotions en ce moment ? Quel besoin non satisfait se cache derrière cette fatigue, cette irritation, cette tristesse ?

Ce geste simple — s'arrêter et s'interroger sur soi — aide à réactiver une forme de recul que le stress chronique tend à court-circuiter.

Pratiquement : Réservez-vous, chaque jour, un moment d'auto-observation, aussi court soit-il. Pas pour "aller mieux tout de suite", mais pour rester en contact avec vous-même. C'est le point de départ de tout le reste.

💡 Conseil n°2 — Poser des limites claires : la CNV comme outil, pas comme performance

Poser des limites dans une famille neurodivergente ne ressemble pas à poser des limites dans une famille "standard". Les personnes autistes ont souvent du mal à lire les sous-entendus, les

silences significatifs, les signaux non verbaux. Ce qui fonctionne dans d'autres couples — un soupir, un regard, une distance — ne fonctionne pas ici.

La CNV offre une structure adaptée : exprimer une **Observation, un Sentiment, un Besoin, une Demande** (OSBD) de manière claire et directe, sans reproche ni injonction. Non pas "tu ne fais jamais attention à moi" mais "quand la maison est bruyante pendant deux heures, je me sens saturée, j'ai besoin de silence pour me ressourcer — est-ce que tu peux prendre le relais une heure ce soir ?"

Ce n'est pas une formule magique. C'est un apprentissage. Mais il correspond au mode de communication littérale que les personnes autistes comprennent souvent mieux que le langage implicite.

Et lorsque vous êtes vous-même TDAH : exprimer vos besoins clairement est aussi un acte de régulation pour votre propre cerveau — qui, en formulant un besoin précis, mobilise les fonctions exécutives et réduit la charge anxieuse diffuse.

💡 Conseil n°3 — Réinventer le couple et la famille : rien ne vous oblige à faire comme tout le monde

C'est peut-être le conseil le plus libérateur — et le plus rare à entendre.

Une famille atypique n'a pas à fonctionner comme une famille neurotypique.

Certains modèles familiaux "standards" peuvent être incompatibles avec certaines configurations neurodivergentes. Les temps familiaux forcés, la fusion permanente du couple, la chambre partagée imposée par la norme sociale — autant de configurations qui peuvent être sources d'épuisement pour les deux partenaires, sans que personne ne les remette en question.

Voici ce qui peut fonctionner, et qui fonctionne — dans mon expérience :

Les chambres séparées. Loin d'être un signe d'échec conjugal, elles permettent à chacun de préserver son espace sensoriel et cognitif. Pour une personne autiste, la nuit partagée peut être une source de surcharge sensorielle. Pour un conjoint TDAH, la fatigue d'une nuit perturbée peut compromettre la régulation du lendemain. Un couple peut rester profondément uni — et dormir séparément. Vingt-sept ans de vie commune en témoignent.

Les activités en parallèle. Ne pas tout faire ensemble n'est pas une rupture du lien. C'est le respect de deux fonctionnements différents. Chacun dans son monde, avec ses intérêts, ses besoins de stimulation ou de calme — et des moments partagés choisis, non subis.

Les moments familiaux non forcés. Obliger une réunion familiale lorsqu'une personne autiste est en surcharge sensorielle ou qu'un enfant TDAH déborde émotionnellement produit souvent l'inverse de l'effet recherché. Laisser chacun vaquer à ses occupations n'est pas un échec éducatif. C'est une adaptation au fonctionnement réel de chacun.

La recherche sur le **réseau du mode par défaut** — un réseau cérébral actif lors des moments de calme et de solitude choisie — montre que ces espaces jouent un rôle dans la créativité, la

consolidation mémorielle et la régulation émotionnelle. Une nuance importante : solitude choisie et isolement subi n'ont pas les mêmes effets sur le cerveau.

Pratiquement : Interrogez-vous sur chaque "norme" de vie familiale que vous appliquez. Vient-elle de vous, de votre histoire, de ce que vous croyez qu'il "faut faire" — ou est-elle réellement adaptée au fonctionnement de chacun dans votre foyer ? La liberté commence souvent là.

Pour terminer — ou plutôt pour commencer

Vous avez choisi d'aimer quelqu'un dont le cerveau fonctionne différemment. Vous avez choisi d'accompagner vos enfants dans leur singularité. Vous avez appris, compris, adapté.

Maintenant il est temps de vous poser la seule question qui compte vraiment :

Est-ce que quelqu'un, quelque part, s'occupe aussi de vous ?

Si la réponse est non — ou "pas vraiment" — alors cet article, et la conversation qu'il ouvre, est un premier pas.

Cet article s'appuie sur une expérience personnelle vécue, croisée avec des éléments issus de la littérature scientifique sur l'aidance et les neurosciences. Il ne vise pas une généralisation scientifique, mais à rendre visible une réalité encore peu documentée : celle des aidants qui sont eux-mêmes neurodivergents.

Sources : Hans Selye (syndrome général d'adaptation, 1936) · Marshall Rosenberg (Communication Non Violente) · Nathan Spreng / Université McGill (réseau du mode par défaut, Nature Communications) · Fondation pour la Recherche sur le Cerveau (stress chronique) · Rudy Simone (22 Things a Woman Must Know If She Loves a Man with Asperger's Syndrome, 2009)

> **La suite de cet article** abordera d'autres conseils pratiques : maintenir une identité en dehors du rôle d'aidant, trouver du soutien sans se justifier, et naviguer dans les ressources existantes avec lucidité.

Titre Mediapart (78 caractères) : Et toi, qui prend soin de toi ? Le grand oubli des aidants neurodivergents

Chapô Mediapart (397 caractères) : Conjoint autiste, enfants TDAH, soi-même HPI : de nombreuses personnes vivent cette triple aidance invisible, sans ressources adaptées, sans accompagnement, et sans que personne ne leur demande comment elles vont. Cet article part d'une expérience vécue de l'intérieur pour nommer ce que les manuels n'abordent pas — et proposer des outils concrets, ancrés dans les neurosciences et la CNV.

Mots-clés : autisme, Asperger, TDAH adulte, aidant naturel, proche aidant, neurodiversité, épuisement de l'aidant, caregiver burnout, HPI, famille neurodivergente, CNV, Communication

Non Violente, neurosciences, chambre séparée, couple atypique, santé mentale, Cassandra Affective Disorder, répit aidant, développement personnel, Rudy Simone

Prompt illustration (style réaliste/photo — registre témoignage intime) : A woman sitting alone at a kitchen table at night, hands wrapped around a cup of tea, looking into the distance. Warm but tired expression. Soft light. The house behind her is calm but full — a child's drawing on the wall, a book on autism on a shelf. Navy blue and terracotta tones. Photorealistic, intimate, no text.